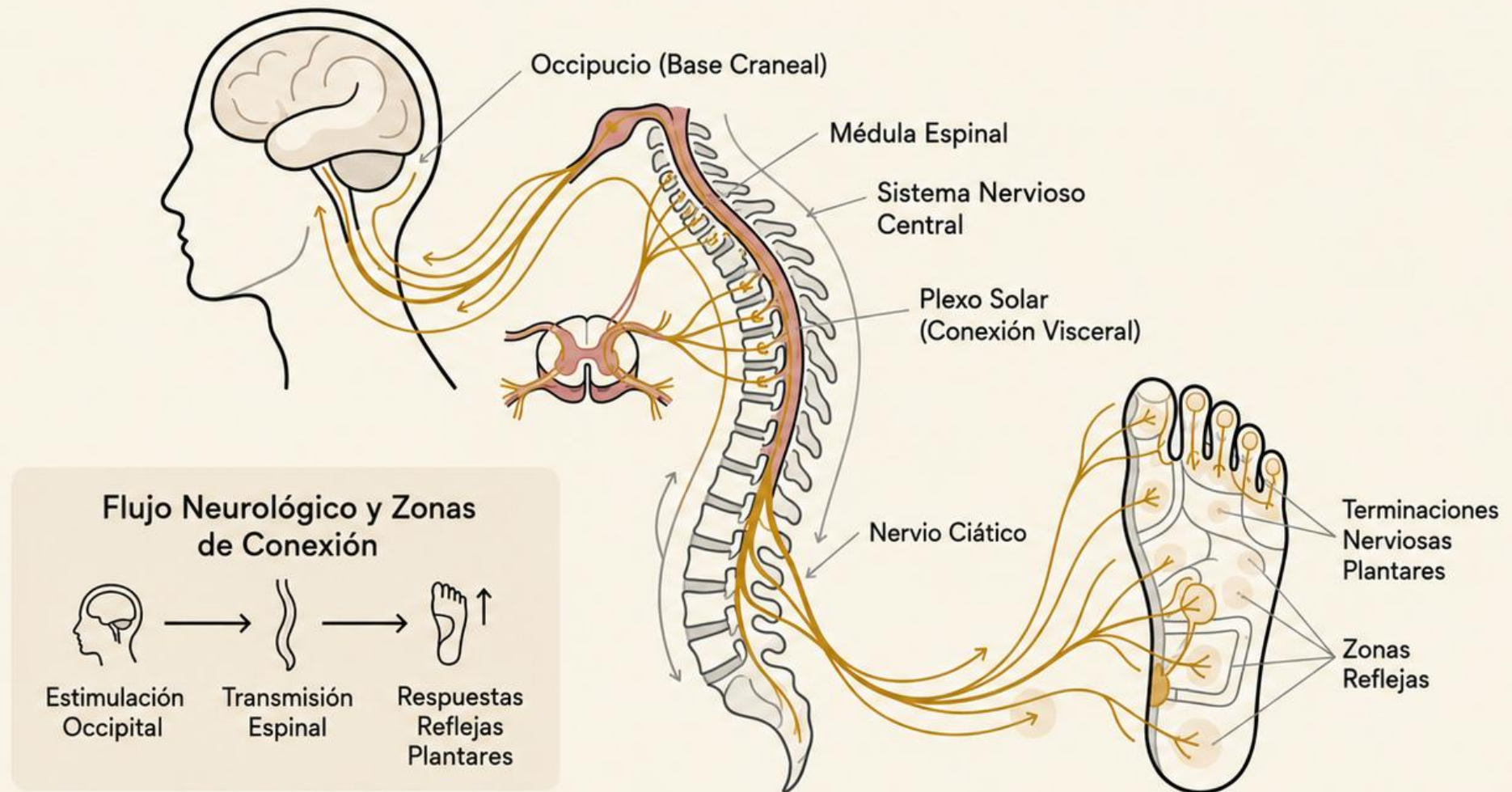


Tratamiento mediante la Reflexoterapia Occipito-Podal (ROP)

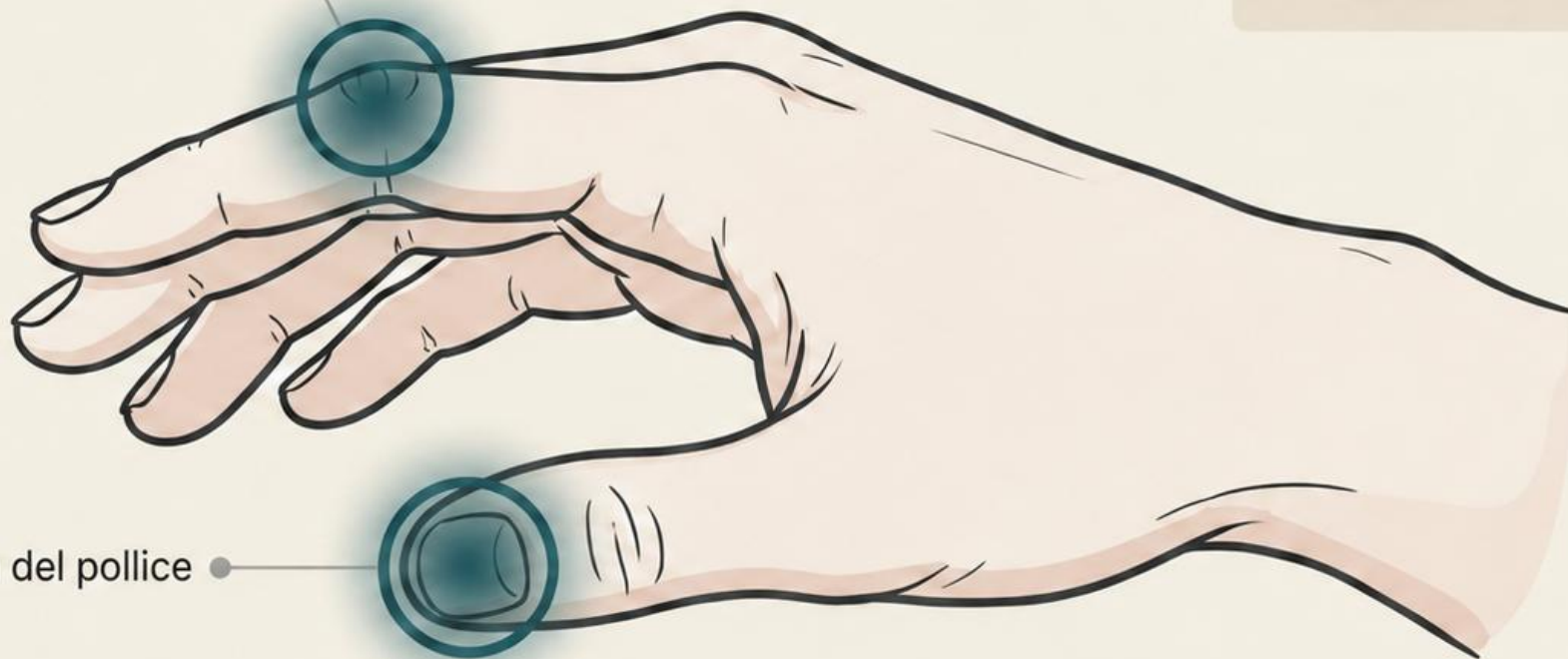
Capítulo 2 — Principios, Cartografía y Aplicación Clínica



L'Importanza del Gesto Terapeutico

Articolazione interfalangea
prossimale dell'indice

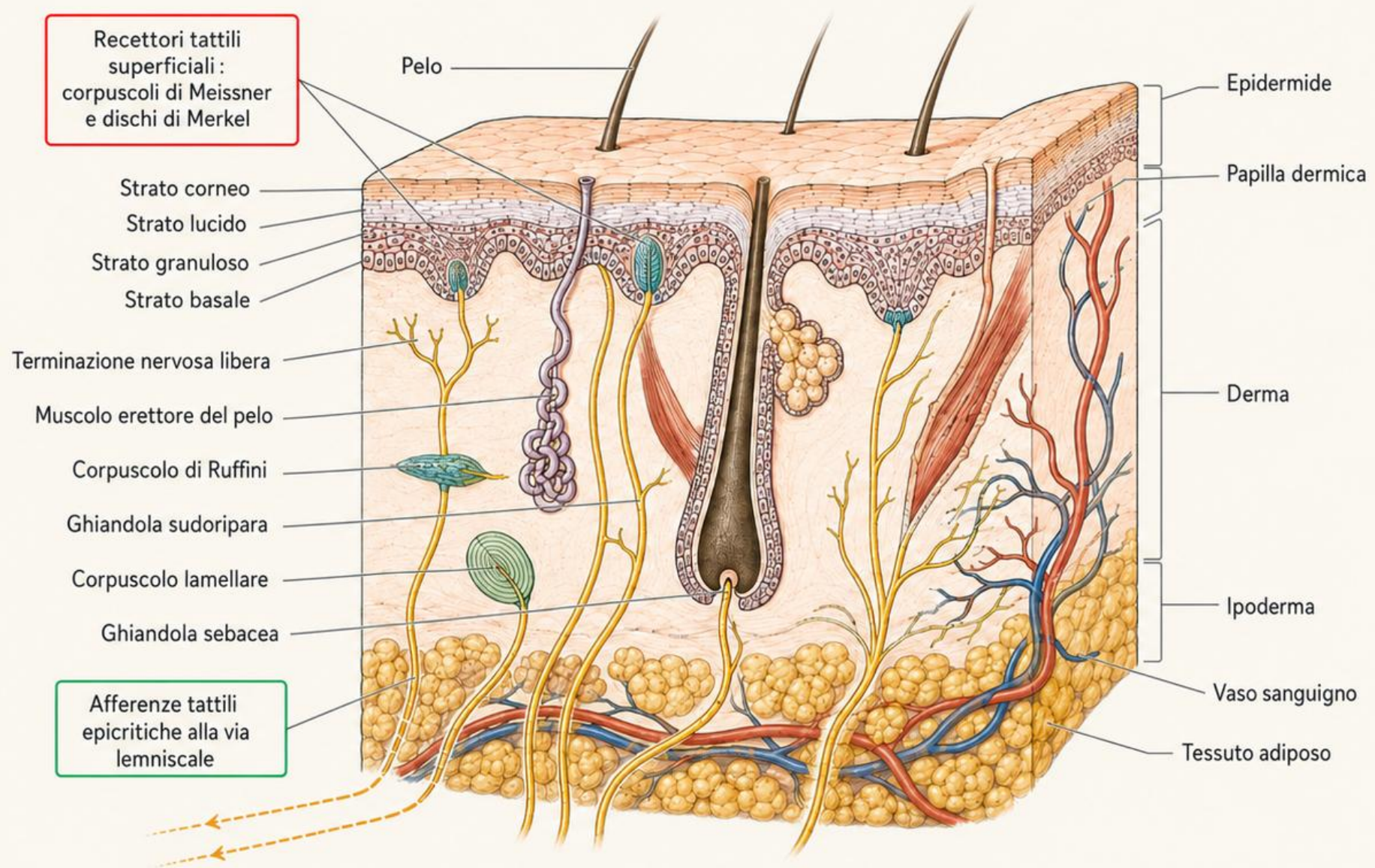
Polpa del pollice



Un approccio esclusivamente manuale, senza l'ausilio di olio o crema, basato sulla precisione della pressione epicritica.

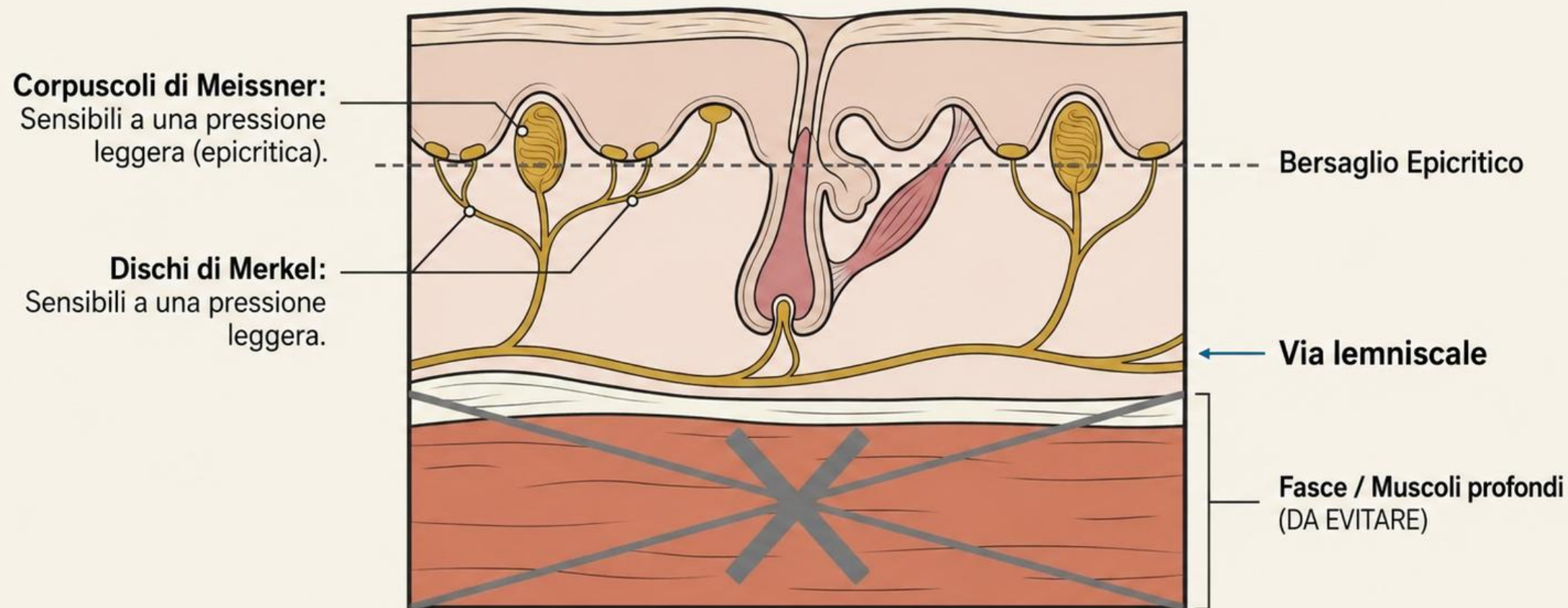
Sono prescritte forza e frizione. La pressione è forte, mentre la lettura dei riferimenti ossei e delle aree riflesse è mirata.

La pelle



Rappresentazione schematica degli strati della pelle, dei suoi annessi e dei suoi principali recettori tattili superficiali.

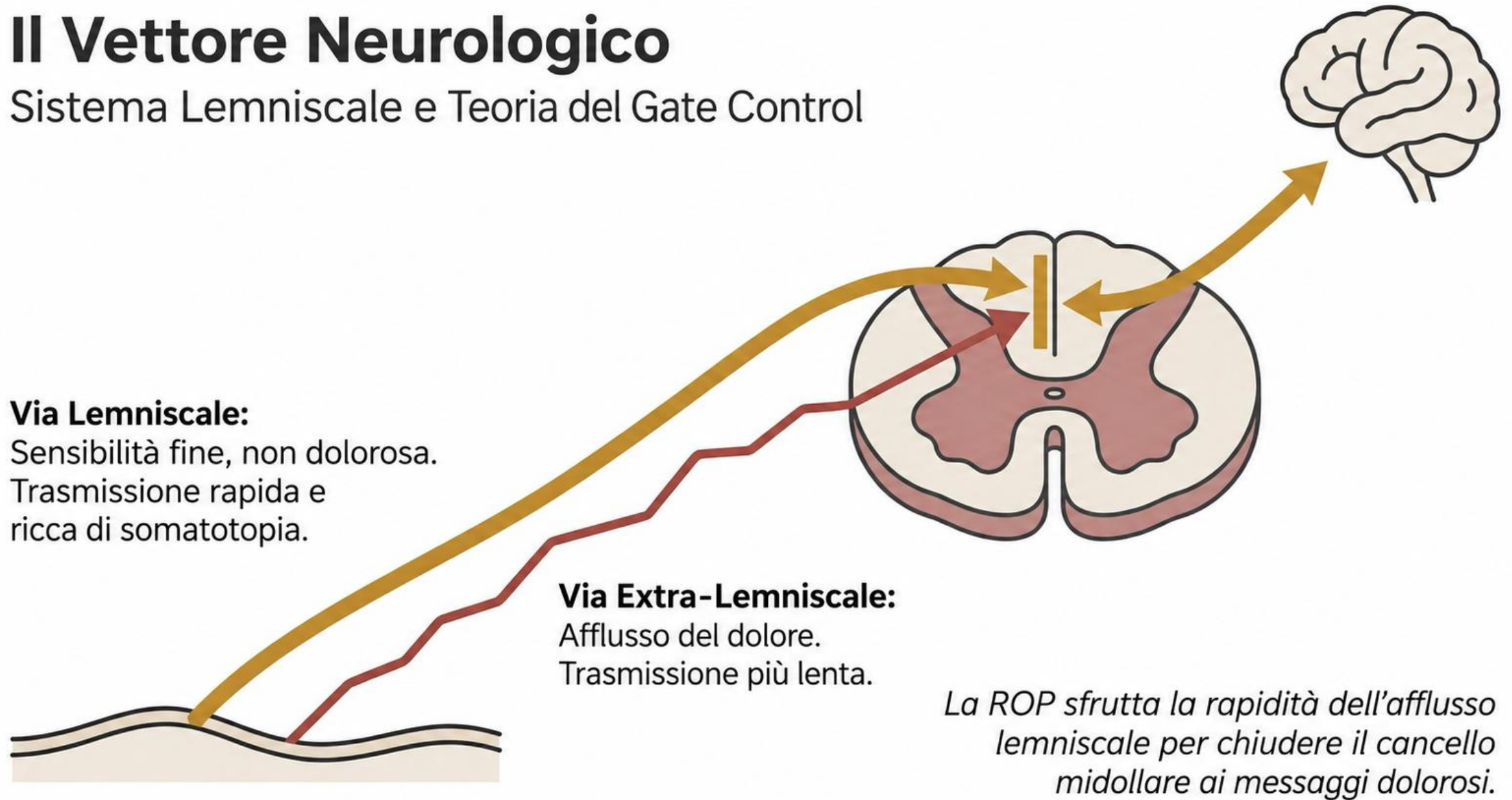
Il Bersaglio Tessutale: Strato Epidermico-Dermico



L'obiettivo è deformare la pelle percepita dalla sensazione di "pelle di tamburo".
Maggiore è la pressione, meno sono leggibili i reperi ossei.

Il Vettore Neurologico

Sistema Lemniscale e Teoria del Gate Control



Cronología Clínica: Los Tres Tiempos del Masaje



Tiempo del Diagnóstico Textural

Acción : Búsqueda de rugosidades, densificaciones y pérdidas de deslizamiento.

Respuesta del paciente : Sensación de pequeñas picaduras características.



Tiempo Terapéutico

Acción : Presión fina, epicrítica. Movilización de la capa epidérmico-dérmica.

Objetivo : Solicitar los mecanorreceptores (sin dolor vivo, sinónimo de sobredosis de masaje).



Tiempo de “Dejar Hacer”

Acción : Tiempo de latencia post-estimulación. No hacer nada.

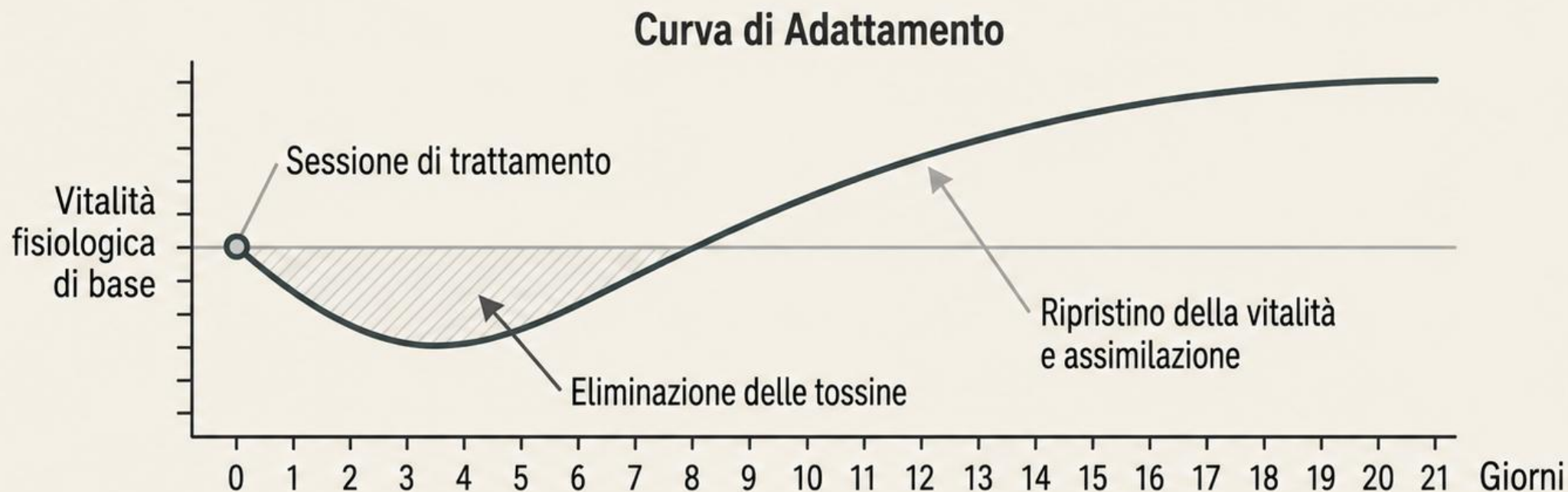
Objetivo : Permitir que el organismo integre las adaptaciones neurovegetativas.

Resultado : Relajación restaurada.



La Finestra di Assimilazione Neuro-Vascolare

Perché è richiesto un intervallo di 3 settimane?



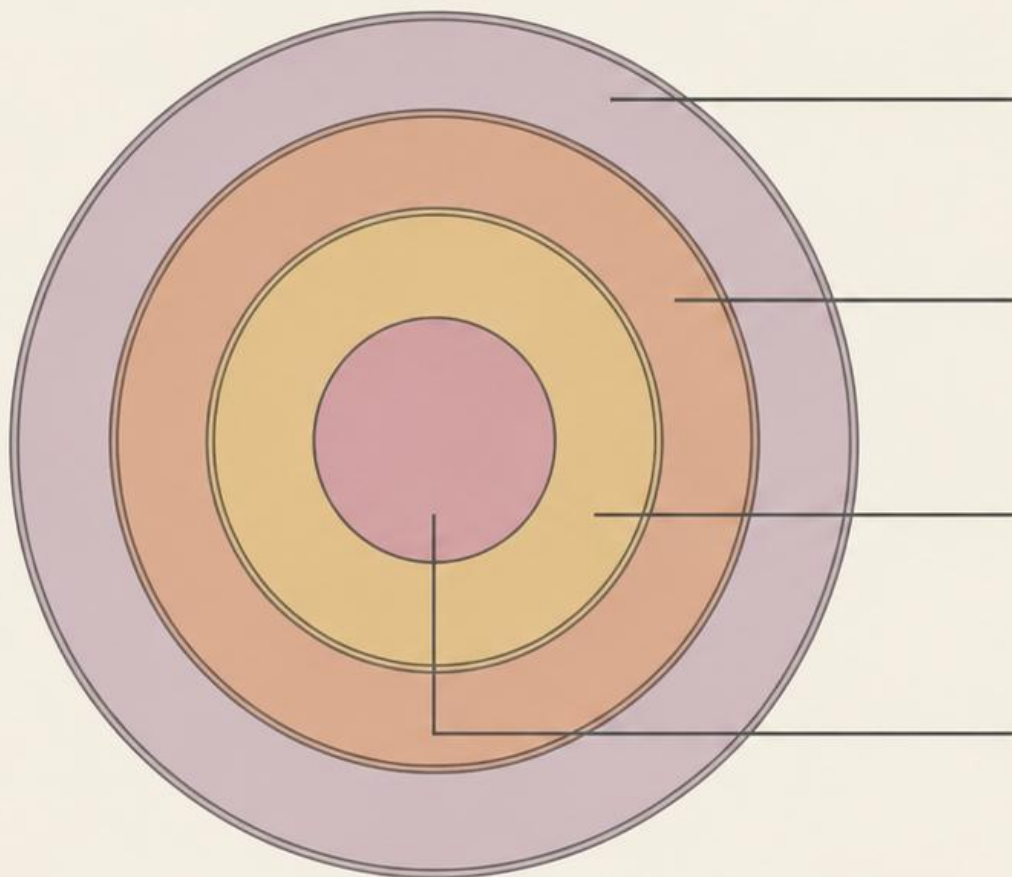
24–48 ore: Possibili reazioni transitorie (dolori muscolari, affaticamento, sogni, ecc.). Testimoniano la risposta allo stress positivo e l'eliminazione tossica.

Settimane successive: Adattamento del sistema immunitario, ormonale e psichico.

Cure troppo ravvicinate non lasciano il tempo ai processi neuro-vascolari e strutturali di riportare la fisiologia nei tessuti profondi. In genere sono sufficienti 3 sessioni.

Gerarchia del Piano di Trattamento

Il protocollo rigido non esiste in un approccio olistico.



1. Urgenze & Sequele: Post-trauma, chirurgia, infezione (priorità immediata).

2. Fissazioni Dominanti: Identificate dall'anamnesi e dai test d'ascolto globale/locale.

3. Sfera Psico-Emotiva: Traumi antichi irrisolti (amigdala / ippocampo).

4. Contesto Generale (SGA): La storia completa degli adattamenti dell'individuo.

Cartografia d'intervento

Le tre sfere riflesse occipito-podali

1. Sindrome Generale di Adattamento (SGA)

Occipite-C1-C2, nervo vago (X), falce cerebrale, MRP, sistema venoso.

Obiettivo: Sostenere la regolazione neurovegetativa globale.



3. Sistema Limbico

Amigdala, ippocampo, insula.
Equilibrio cervello-visceri.

Obiettivo: Integrare la dimensione dello stress e la memoria corporea.

2. Sindrome Locoregionale

Plesso prevertebrale, plessi somatici, cavità addominale e pelvica.

Obiettivo: Trattare i circuiti viscerosomatici.

Obiettivi Anatomici I: Sindrome Generale di Adattamento

Sostenere la regolazione neuro-vegetativa prima del trattamento del tessuto locale.

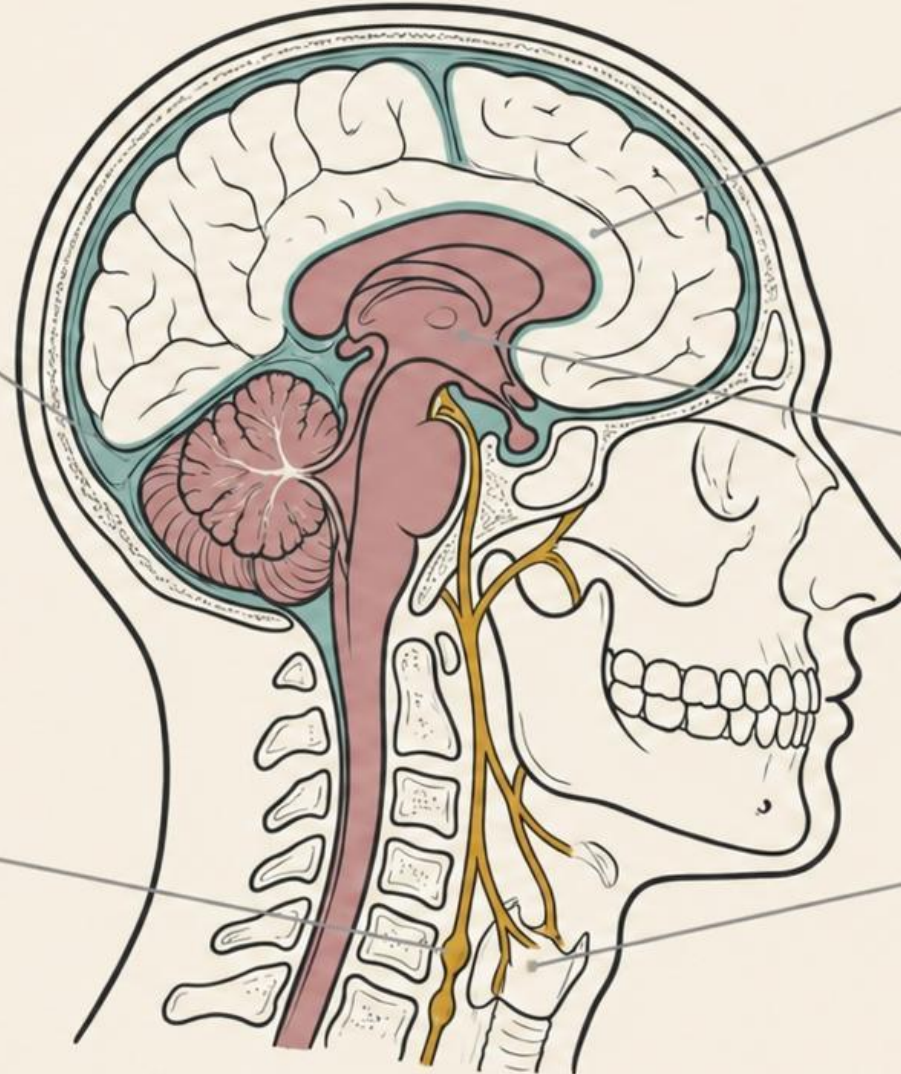
RMP (Meccanismo Respiratorio Primario): Occipite-C1-C2, nervi V, X, XII, falso del cervello.

Liquido Cefalo-Rachidiano: Sistema venoso, compressione del IV ventricolo, sincronizzazione SSB-S2.

Centri Superiori: Diencefalo, tronco cerebrale, ipofisi.

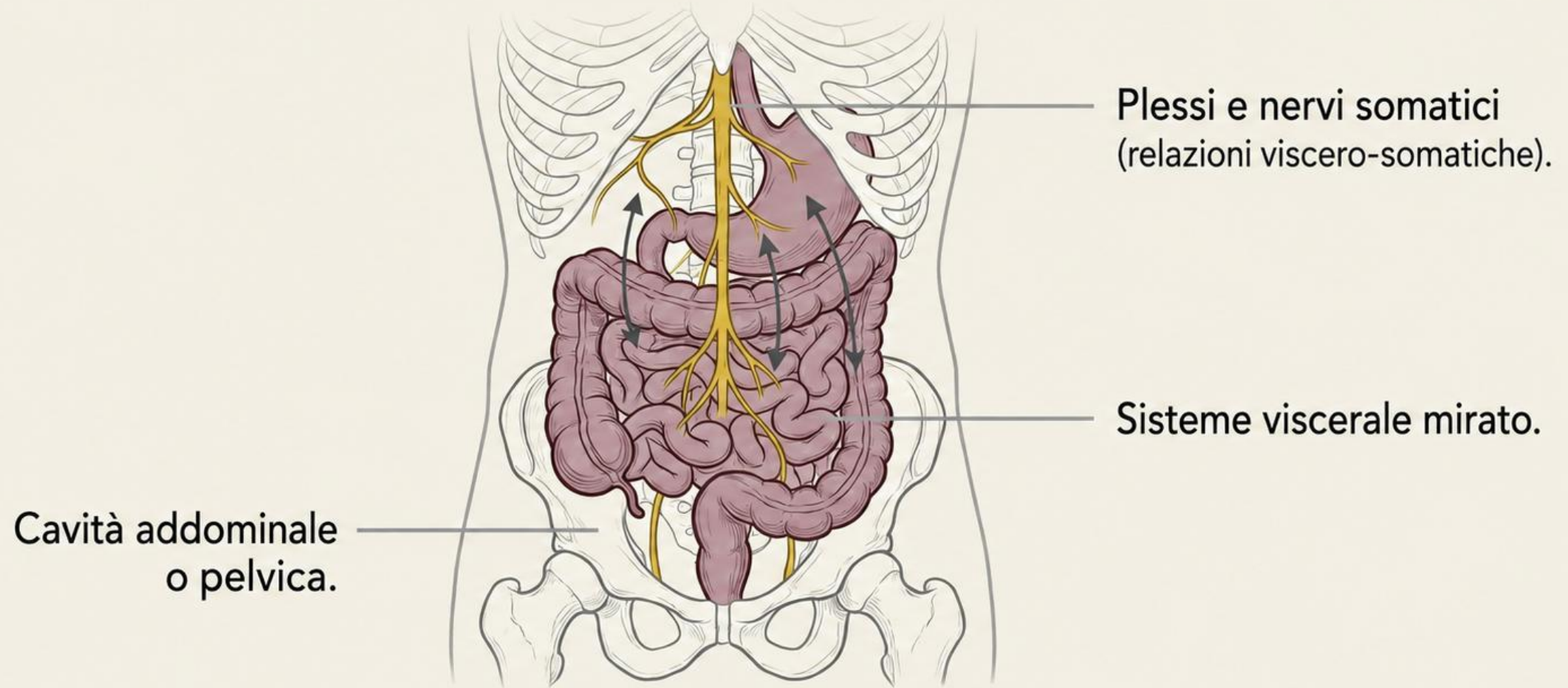
Innervazione Simpatica: Colonna vertebrale, catena gangliare latero-vertebrale.

Sistema Neuro-Vegetativo: Nervo vago (forame giugulare, esofageo), parasimpatico pelvico.



Obiettivo II: Sindrome locoregionale

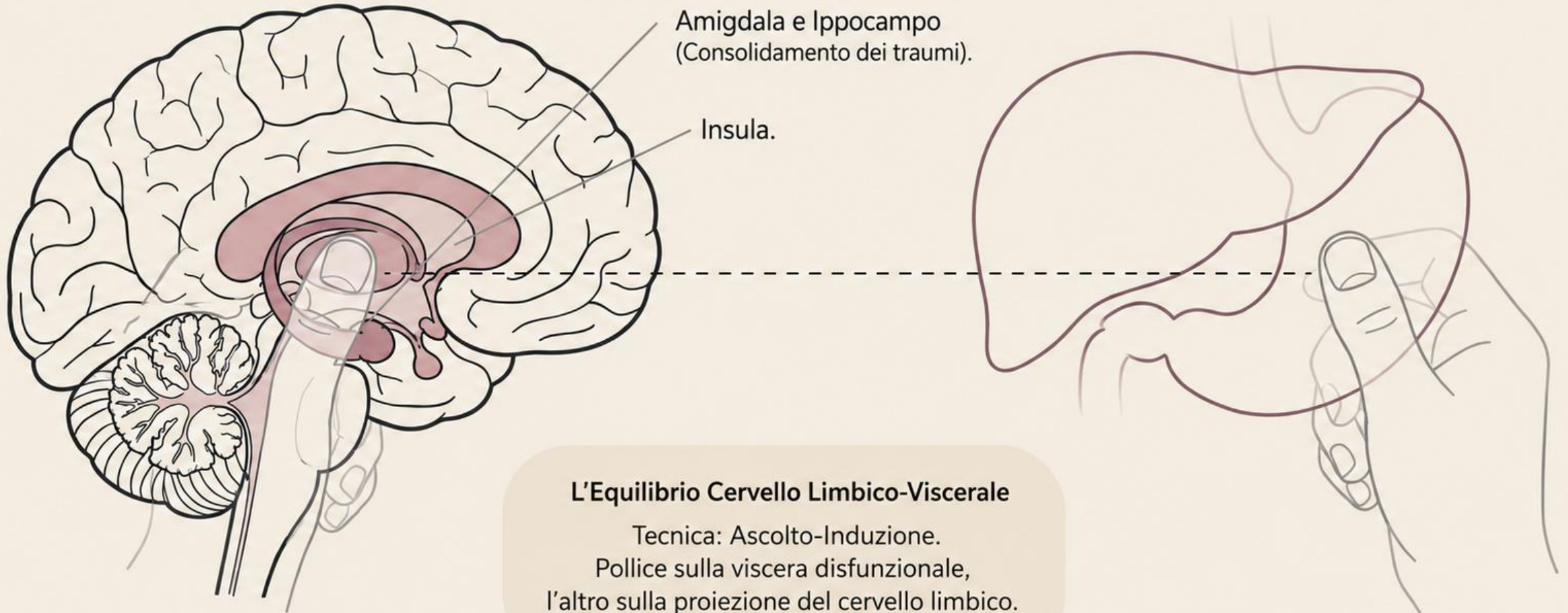
Trattamento dei circuiti legati alla regione sintomatica.



L'obiettivo è rilasciare le fissazioni locali della cavità interessata per ripristinare la mobilità tissutale e interrompere il circuito neurovegetativo mantenuto dalla disfunzione.

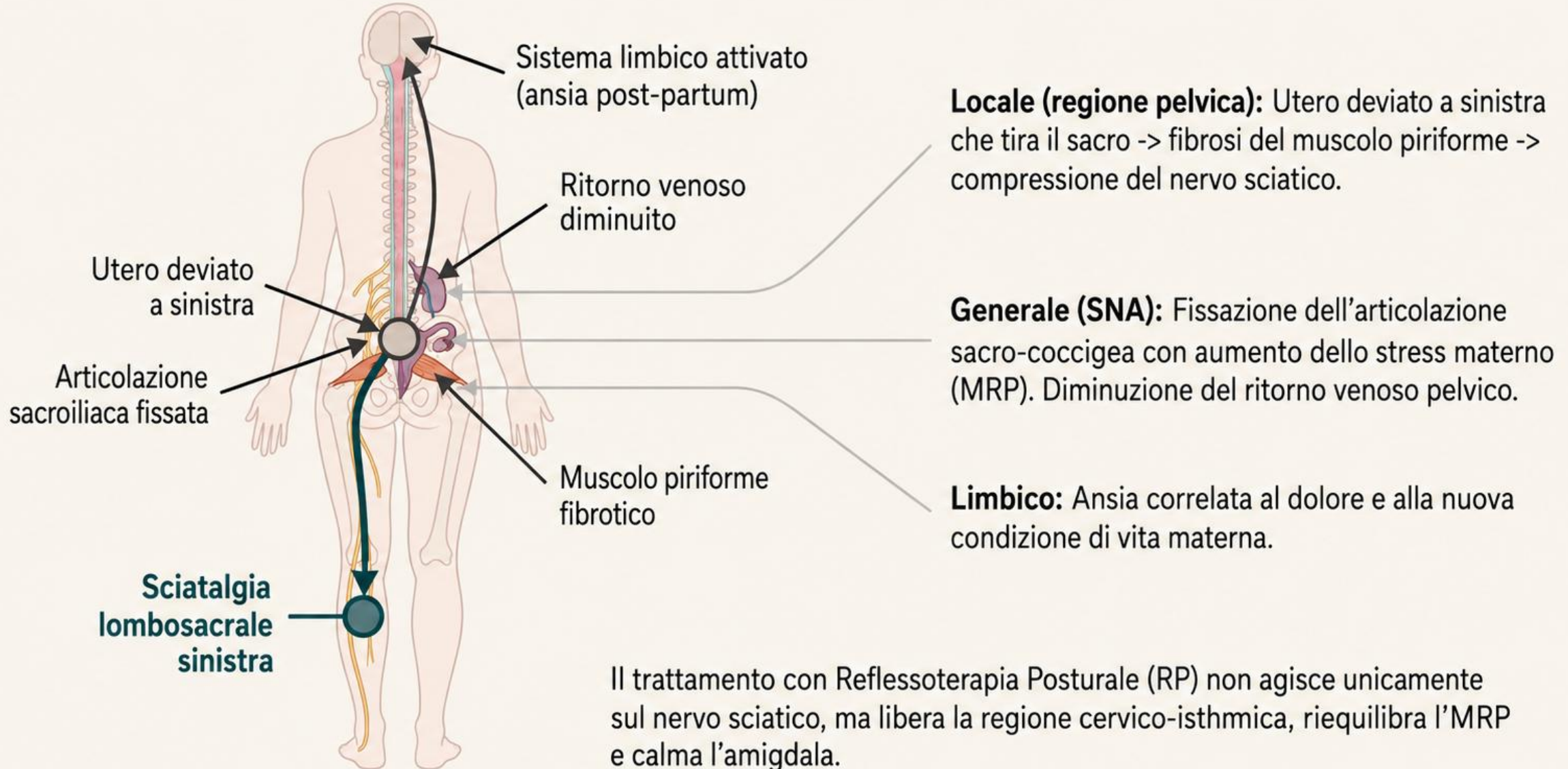
Obiettivo III: Sistema Limbico

Integrazione della memoria corporea.



Applicazione clinica: Sciatalgia lombosacrale post-partum

Paziente unilaterale, dolore intenso secondo il decorso del nervo, posizione seduta prolungata.



Il piano di trattamento ROP mirato per la Signora X

Pilastro 1: Sindrome generale — fondamento

- Meccanica Respiratoria Primaria (MRP)
- Diencefalo e Tronco encefalico
- Asse ormonale: Ipofisi, Surreni
- Ritorno venoso: Fegato, Rene sinistro
- Colonna vertebrale

Pilastro 2: Sindrome locoregionale — meccanica

- Regione cervico-ischiemica dell'utero
- Articolazioni pelviche (sacroiliache, sacrococcigee)
- Muscolo piriforme e legamenti sacrotuberale/sacrospinoso
- Nervo pudendo e plesso sciatico sinistro

Pilastro 3: Sistema limbico — integrazione

- Amigdala
- Ippocampo
- Insula

Piano di Trattamento ROP (Caso della Sig.ra X)

Viscerale & Vascolare

Torace/Addome: Surreni, colonna vertebrale, fegato, rene sinistro.

Sindrome Generale & Limbico

Cranio: MRP, diencéfalo, tronco cerebrale, ipofisi.

Limbico: Amigdala, ippocampo, insula.

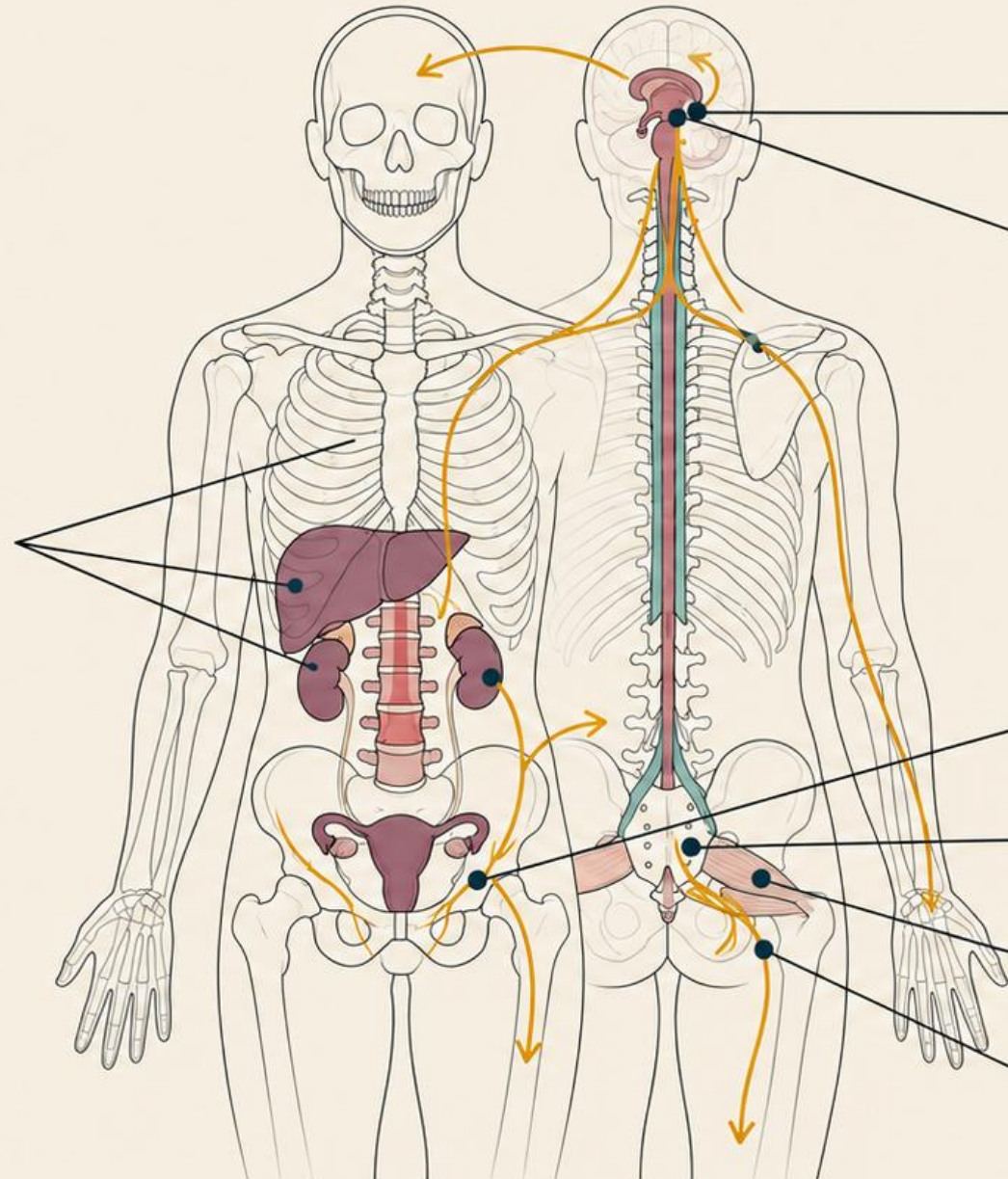
Sindrome Locoregionale

Pelvi: Regione cervico-ischiemica dell'utero.

Articolazioni: Articolazione ilio-sacrale, articolazione sacro-coccigea.

Muscoli/Ligamenti: Piriforme, legamenti sacro-tuberose e sacro-spinoso.

Nervi: Nervo pudendo, plesso sacrale, nervo sciatico sinistro.

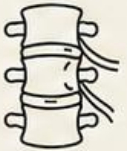


Indicazioni terapeutiche: il campo dei disturbi funzionali reversibili

La ROP eccelle negli squilibri del sistema vascolo-nervoso che insorgono a monte della malattia, quando l'alterazione anatomica tissutale non è ancora iniziata.



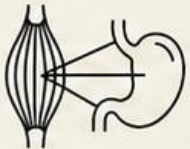
Dolori muscoloscheletrici: Lombalgie, cervicalgie, tensioni croniche senza significativa compromissione strutturale.



Esiti post-traumatici: Disturbi osteo-muscolo-articolari, o coinvolgimenti reversibili dei nervi spinali e cranici.



Disfunzioni viscerali: Circuiti neurovegetativi e fissazioni tissutali che ostacolano la motilità degli organi.



Disturbi somatoviscerali: Dolori riferiti tra il soma e le cavità viscerali metameriche.



Terreno neurovegetativo: Stress emotivo, ansia e disregolazione della Sindrome Generale di Adattamento.

Governance Clinica: Sicurezza e Limiti

✓ Indicazioni (Cure Funzionali)	✚ Segni di Allarme (Richiesta Valutazione Medica)
Patologie reversibili ed extracellulari.	Dolore non meccanico, peggiore di notte.
Dolori muscolo-scheletrici e sequele di traumi.	Dolore toracico atipico, dispnea.
Disfunzioni viscerali e squilibri neurovegetativi.	Sangue nelle urine/feci, febbre, perdita di peso inspiegata.
Stress emotivo e ansia.	Deficit neurologico (disturbi degli sfinteri/sensitivi).
Supporto integrativo (es.: limitazione degli effetti iatrogeni post-chirurgici).	

Primum non nocere. Ogni sospetto di patologia organica impone la riorientazione médica.

Accompagnamento Globale del Paziente



Riposo e Recupero (RRP):

Evitare sovraccarichi fisici nell'arco della giornata.



Salute Mentale: Diventare protagonisti della propria salute, coltivare pensieri positivi, vita sociale arricchente.

*« Prima di cercare di curare qualcuno, chiedigli se è pronto a rinunciare alle cose che lo hanno reso malato. »
— Ippocrate*



Stile di Vita e Igiene:

Alimentazione sana, idratazione adeguata, attività fisica regolare.



Auto-osservazione: Annotare l'evoluzione in vista del prossimo appuntamento (dolore 0-10, sonno, transito, energia). L'obiettivo guida le decisioni e la gerarchia future.